

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENGELOLAAN SISA MAKANAN PASIEN		
	No. Dokumen 1082/RSPHS/I-SPO/DIR/XII/2025	No. Revisi 00	Halaman 1 / 4

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 20 Desember 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep.,M.Kep
Pengertian	Pengelolaan sisa makanan pasien adalah rangkaian kegiatan penimbangan, pencatatan, pembuangan, dan analisa sisa makanan pasien rawat inap yang bertujuan untuk menilai daya terima makanan, kecukupan asupan gizi, serta peningkatan mutu pelayanan gizi rumah sakit.	
Tujuan	1. Mengukur Tingkat sisa makanan pasien secara objektif 2. Menilai daya terima dan kualitas makanan pasien 3. Mengidentifikasi masalah asupan gizi pasien secara dini 4. Mendukung upaya peningkatan mutu pelayanan gizi dan keselamatan pasien.	
Kebijakan	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga. 2. Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 231/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelayanan Gizi	
Prosedur	A. Persiapan 1. Siapkan timbangan makanan yang bersih dan terkalibrasi 2. Sediakan formulir pencatatan sisa makanan pasien 3. Gunakan alat pelindung diri (APD) sesuai ketentuan. B. Penimbangan Sisa Makanan 1. Ambil tempat makan pasien setelah waktu makan selesai. 2. Pisahkan sisa makanan dari alat makan dan sampah non-makanan. 3. Timbang sisa makanan sesuai jenis hidangan (makanan pokok, lauk, sayur, buah). 4. Catat hasil penimbangan pada formulir sisa makanan pasien. 5. Pastikan identitas pasien dan waktu makan tercantum dengan benar.	

C. Pembuangan Sisa Makanan

1. Masukkan sisa makanan ke dalam wadah limbah organik tertutup.
2. Lakukan pembuangan sesuai dengan prosedur pengelolaan limbah rumah sakit.
3. Bersihkan area penimbangan dan peralatan setelah digunakan.
4. Lakukan cuci tangan sesuai prosedur higienis.

D. Rekapitulasi dan Analisa oleh Ahli Gizi

1. Kumpulkan data sisa makanan pasien setiap hari.
2. Hitung persentase sisa makanan dari total porsi yang disajikan
3. Identifikasi sisa makanan $\geq 20\%$ sebagai indikasi masalah daya terima.
4. Analisa penyebab sisa makanan meliputi :
 - a. Jenis diet
 - b. Cita rasa dan tampilan makanan
 - c. Kondisi klinis pasien
 - d. Jadwal pemberian makan
5. Lakukan assesmen ulang status gizi pasien bila diperlukan.

E. Tindak Lanjut

1. Berikan rekomendasi perbaikan menu atau modifikasi diet
2. Koordinasikan hasil Analisa dengan DPJP dan perawat ruangan.
3. Gunakan hasil Analisa sebagai bahan evaluasi mutu pelayanan gizi
4. Laporkan rekapitulasi sisa makanan secara berkala kepada manajemen.

F. Keselamatan dan Mutu

1. Terapkan prinsip hygiene dan sanitasi dalam seluruh proses
2. Pastikan tidak terjadi kontaminasi silang selama penimbangan.
3. Gunakan data sisa makanan sebagai indikator mutu pelayanan gizi.

Unit Terkait

Instalasi Gizi
Instalasi Rawat Inap

Lampiran 1 – Kalsifikasi Derajat Komplain

Warna	Derajat/ karakteristik	Contoh Komplain	Penanggung Jawab Penanganan	Waktu Penyele saian	Bentuk Penyelesaian
Hijau	Derajat I Komplain ringan, tidak berdampak klinis, dapat diselesaikan langsung di unit	Waktu tunggu lama, pelayanan lambat, informasi kurang jelas	Petugas/ Kepala Unit/ Koordinator Unit	1x24 jam	Penjelasan langsung, klarifikasi perbaikan cepat
Kuning	Derajat II Komplain sedang, berdampak pada kepuasan atau proses pelayanan, memerlukan klarifikasi lintas unit	Sikap petugas tidak sopan, ketidaktepatan prosedur, pelayanan tidak sesuai standar	Kepala unit/ MOD/ Penanggung jawab pelayanan	3x24 jam	Klarifikasi, pertemuan, tindak lanjut lintas unit, jawaban tertulis/ lisan
Merah	Derajat III Komplain berat, berdampak luas atau berpotensi hukum, menyangkut keselamatan pasien atau reputasi rumah sakit	Dugaan malpraktik, kerugian besar, keluhan ke media, ancaman hukum	MOD/ Direksi/ Bagian Hukum/ Tim Mutu	7x24 jam	Investigasi, RCA, rapat manajemen, jawaban resmi tertulis, rekomendasi perbaikan sistemik

